

# 仿單外使用 (off-label)：醫師為什麼會建議？病人能不能用？

*Off-label drug use in oncology: why doctors prescribe and what patients should know*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：腫瘤藥物仿單外使用 (Off-label drug use in oncology)

DOI: 10.5281/zenodo.20131237 · 此版本 10.5281/zenodo.20131238 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/off-label-cancer-drug-use/>

## 摘要 · ABSTRACT

off-label = 藥物用於「未經主管機關核准的適應症、劑量、年齡或給藥途徑」。腫瘤領域 off-label 比例極高 (30–50%)，原因包括 NCCN compendium 已收錄但 FDA / TFDA 尚未核准、罕見癌缺臨床試驗、新適應症在他國已核准。本文整理 off-label 與 unapproved 的差別、健保 / 自費 / PAP 給付邏輯、IRB 與 informed consent。

**Off-label (仿單外使用) = 藥物已合法核准、但用於未列入仿單的適應症、劑量、年齡或給藥途徑。** 腫瘤領域 off-label 比例極高 (30–50%)，多有 NCCN compendium、大型試驗或 case series 支持。本文釐清 off-label 與 unapproved 的差別、為什麼腫瘤特別多 off-label、健保 / 自費 / PAP / 恩慈的給付路徑、與「醫師建議 off-label 時該問什麼」。

## 閱讀對象

本文設定讀者為被主治醫師建議 off-label 用藥的病友與家屬。實際處方決策由主治醫師依個案判斷；本文不取代專業諮詢。



## off-label vs. unapproved：兩個常被混淆的概念

| 概念                           | 藥物是否核准？ | 用法是否列在仿單？ | 例子                                           |
|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|
| on-label                     | ✓       | ✓         | trastuzumab 用於 HER2+ 乳癌                      |
| off-label                    | ✓       | ✗         | trastuzumab 用於 HER2+ 胃癌（部分線數）、salivary gland |
| investigational / unapproved | ✗       | —         | 試驗藥；新分子                                      |
| compassionate use            | ✗ 在台灣   | —         | 透過 TFDA 個案申請                                 |

## 為什麼腫瘤特別多 off-label？

1. **NCCN compendium**：NCCN（美國最大腫瘤指引組織）收錄了大量「有實證但仿單未列」的用法。例如：rituximab 用於眾多 B 細胞淋巴瘤亞型、bevacizumab 用於多種癌、TKI 跨適應症使用。
2. **罕見癌缺試驗**：罕見癌人數少，無法做隨機試驗證明適應症；只能靠 case series 與小型試驗。
3. **新適應症在他國已核准**：FDA 早台灣 1-2 年核准新適應症的情形常見。
4. **NGS 後罕見變異**：NTRK、ROS1、RET、BRAF、HER2 等變異跨多癌別有效，但每個小亞群人數少，仿單不一定逐一收錄。

## 常見 off-label 範例（腫瘤）

| 藥物                      | 仿單適應症        | 常見 off-label                           |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Trastuzumab             | HER2+ 乳癌     | HER2+ 胃癌（部分線數）、唾液腺癌、肺癌 HER2+           |
| Rituximab               | B 細胞 NHL、CLL | 多種自體免疫疾病、Waldenström macroglobulinemia |
| Bevacizumab             | 大腸、肺、卵巢、腎細胞癌 | 第二線後使用、罕見肉瘤                            |
| Pembrolizumab           | 多適應症         | MSI-H / dMMR 跨癌（部分已轉 on-label）         |
| Olaparib                | BRCA+ 乳卵巢攝護腺 | HRD+ 其他癌                               |
| Sotorasib / Adagrasib   | KRAS G12C 肺癌 | KRAS G12C 大腸（部分線數已轉 on-label）          |
| Cetuximab / Panitumumab | RAS WT 大腸    | 頭頸癌維持線數                                |

## 法源與規範

| 國家 / 機構         | 規範                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 美國 FDA          | 「FDA 不規範醫師處方」；藥廠不可廣告 off-label；但醫師可依專業判斷處方 |
| 台灣 TFDA         | 同上，醫師依《醫師法》得個案判斷                           |
| 健保署             | 給付限「列載適應症」；off-label 多需自費或個案專案             |
| NCCN compendium | 美國多數保險公司以此為核退依據；台灣健保部分認可                   |
| IRB             | off-label 用於系統性研究時需 IRB 審查                 |

## 健保給付路徑（台灣 2026）

### 第一步 — 確認是否屬「擴大適應症」

健保署藥品共擬會議會逐年擴大部分藥的適應症。例如 trastuzumab 從乳癌擴大到胃癌、rituximab 從濾泡淋巴瘤擴大到 DLBCL。

### 第二步 — 事前審查送件

主治醫師依 NCCN compendium、實證資料、生物標記送審。多數高價標靶 / 免疫藥都需事前審查。

### 第三步 — 不通過則探索其他路徑

自費、PAP 病人扶助、藥廠恩慈、商業保險、臨床試驗。

### 第四步 — Informed consent

主治醫師應書面告知 off-label 性質、實證依據、可能副作用、費用結構。

## off-label 的風險

| 風險     | 說明                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| 療效不確定性 | 多數 off-label 證據強度低於 on-label（case series、小型試驗） |
| 副作用差異  | 用於不同癌別、不同病人族群，副作用譜可能不同                         |
| 健保拒絕給付 | 經濟負擔大                                          |
| 保險核退爭議 | 商業保險核退可能挑戰 off-label 合理性                       |
| 不良事件責任 | 醫師與醫療團隊承擔（有 informed consent 為前提）              |

## 該問醫師的 5 個問題

### 1. 這個 off-label 用法有哪些證據？

請主治醫師列出 NCCN compendium、PubMed 文獻、機構經驗。

### 2. 與標準療法的療效預期差別？

ORR、PFS、OS 的合理估計。

### 3. 副作用與標準療法相比？

特別是少見、長期副作用。

### 4. 費用怎麼算？哪些單位會付？

健保事前審查、自費、PAP、商業保險、試驗。

### 5. 如果不做這個 off-label，標準替代方案是什麼？

Plan B 與其差別。

## 與「臨床試驗」「藥廠恩慈」的區別

| 路徑                   | 性質                  | 費用             |
|----------------------|---------------------|----------------|
| on-label 健保給付        | 標準                  | 健保部分負擔（重大傷病可免） |
| off-label 健保給付（事前審查） | NCCN compendium 等支持 | 健保部分負擔         |
| off-label 自費         | 已上市藥用於未核准適應症        | 自費             |
| 臨床試驗                 | 研究藥 / 研究適應症         | 多免費（試驗贊助）      |
| 藥廠恩慈用藥               | 未上市藥個案使用            | 多免費（藥廠提供）      |

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 被建議 off-label 用藥的病友與家屬
- 想了解 off-label 法規架構的同業
- 第一線住院醫師、家醫科衛教

### 本文不適用

- 取代主治醫師對個案的處方判斷
- 個別藥物的詳細副作用清單（請查仿單與 NCCN）

## 副作用 / 風險揭露

---

每種 off-label 用法的副作用譜不同。通用原則：

- 在開始 off-label 前，主治醫師應給予 informed consent
- 監測頻率多需較密集
- 出現非預期副作用立刻回報
- 保留書面 informed consent 與診療紀錄

### 主要禁忌

- 對該藥已知過敏
- 嚴重共病、ECOG 3–4
- 懷孕（依藥物個別評估）
- 與其他藥物嚴重交互作用



## 參考文獻

---

1. Stafford RS. **Regulating Off-Label Drug Use — Rethinking the Role of the FDA.** *N Engl J Med.* 2008;358(14):1427–1429. doi:10.1056/NEJMp0802107
2. Conti RM, et al. **Prevalence of Off-Label Use and Spending in 2010 Among Patent-Protected Chemotherapies in a Population-Based Cohort of Medical Oncologists.** *J Clin Oncol.* 2013;31(9):1134–1139. doi:10.1200/JCO.2012.42.7252
3. Egualé T, et al. **Association of Off-label Drug Use and Adverse Drug Events in an Adult Population.** *JAMA Intern Med.* 2016;176(1):55–63. doi:10.1001/jamainternmed.2015.6058
4. National Comprehensive Cancer Network. **NCCN Drugs & Biologics Compendium.** [nccn.org/professionals/drug\\_compendium](http://nccn.org/professionals/drug_compendium)
5. Saiyed MM, et al. **Off-Label Drug Use in Oncology: A Systematic Review of Literature.** *J Clin Pharm Ther.* 2017;42(3):251–258. doi:10.1111/jcpt.12507
6. 衛生福利部食品藥物管理署. **藥品仿單核准適應症外使用（off-label use）參考原則.** [fda.gov.tw](http://fda.gov.tw)

引用整理協力：NCCN compendium、ASCO Off-Label Policy、Conti 2013 JCO、Egualé 2016 JAMA Intern Med、TFDA off-label 參考原則 (2026/05/12)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/off-label-cancer-drug-use/>

CITATION 林協霆. 仿單外使用（off-label）：醫師為什麼會建議？病人能不能用？. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131237

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。